

1. У шестирічної дівчинки, яка хворіє на бронхіальну астму, після відвідування цирку розвинувся напад експіраторної задишки, що супроводжувався свистячими дистанційними хрипами. Оберіть найдоцільнішу тактику для надання невідкладної допомоги дитині.

- A. Інгаляція пульмікورتу через спейсер
- B. Інгаляція сальметеролу по 1-й дозі через спейсер кожні 20 хв протягом 1 год
- C. -
- D. Інгаляція беродуалу по 1-й дозі через спейсер кожні 20 хв протягом 1 год
- E. Інгаляція сальбутамолу по 1-й дозі через спейсер кожні 20 хв протягом 1 год

2. Шестирічній дівчинці встановлено попередній діагноз: міхурово-сечовідний рефлюкс. Яке дослідження треба провести для підтвердження діагнозу?

- A. Мікційну цистографію
- B. Оглядову рентгенографію органів черевної порожнини
- C. Радіоізотопну ренографію нирок
- D. Ультразвукове дослідження нирок
- E. Аналіз крові на вміст креатиніну та сечовини

3. Пацієнта віком 14 років турбують часті запаморочення, біль у ділянці серця, що посилюється під час швидкого ходіння та фізичного навантаження. У сімейному анамнезі був випадок раптової смерті близького родича у віці 35 років, причина смерті батькам пацієнта не відома. Під час фізикального обстеження виявлено посилений серцевий поштовх, систолічний шум на верхівці серця з іррадіацією на основу серця в точку вислуховування аортального клапана. Результати ЕКГ: синусовий ритм із частотою 94/хв, збільшення амплітуди комплексу QRS та негативний зубець Т у II, III та всіх грудних відведеннях. Який найімовірніший діагноз?

- A. Дефект міжшлуночкової перетинки
- B. Дефект міжпередсердної перетинки
- C. Недостатність аортального клапана
- D. Ішемічна хвороба серця
- E. Гіпертрофічна кардіоміопатія

4. У дитини спостерігаються симптоми дефіциту заліза: блідість шкіри, підвищена втомлюваність, порушення апетиту, головокружіння, схильність до частих респіраторних інфекцій. Який метод діагностики потрібно використати для

більш точного визначення рівня вмісту заліза в організмі?

- A. Визначення залізо зв'язуючої здатності сироватки крові
- B. Загальний аналіз крові
- C. Визначення рівня гемоглобіну в сироватці крові
- D. Визначення кольорового показника
- E. Тест на концентрацію феритину в сироватці крові

5. У пацієнтки віком 15 років, яка хворіє на цукровий діабет 1-го типу протягом 10-ти років, спостерігаються підвищена втомлюваність під час ходіння, відчуття печіння в ногах, судом в литкових м'язах, тріщини та виразки на шкірі стоп та гомілок. Яке ускладнення основного захворювання розвинулося в пацієнтки?

- A. Гіпокальціємія
- B. Тромбоз глибоких вен нижніх кінцівок
- C. Тромбофлебіт
- D. Центральна діабетична нейропатія
- E. Діабетична мікроангіопатія нижніх кінцівок

6. Шестирічну дівчинку турбує нападоподібний біль у правому підребер'ї, що виникає через 20-30 хв після вживання їжі, спостерігаються зниження апетиту, підвищена втомлюваність. Під час об'єктивного обстеження виявлено: живіт м'який, безболісний, симптоми Кера та Мерфі слабкопозитивні. Загальний аналіз крові та копрограма без особливостей. Результати біохімічного аналізу крові: загальний білірубін - 20,5 мкмоль/л, прямий - 8,5 мкмоль/л, АлАТ - 0,6 мкмоль/год·мл, alpha-амілаза - 30 мг/год·мл. Результати УЗД: жовчний міхур округлої форми, товщина стінок - 1 мм, незначний осад. Установіть діагноз.

- A. Хронічний панкреатит
- B. Жовчнокам'яна хвороба
- C. Хронічний холецистит
- D. Синдром Жильбера
- E. Дискінезія жовчовивідних шляхів

7. У трирічної дитини захворювання розпочалося гостро, з підвищення температури тіла до 38,2°C, закладеності носа, покашлювання, багаторазового блювання та появи рідких водянистих пінистих випорожнень із кислим запахом, слабко-жовтого кольору, без патологічних домішок, 7-8 разів за добу. Діарея тривала

близько тижня. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A. Ешерихіозу
- B. Шигельозу
- C. Сальмонельозу
- D. Ротавірусної інфекції
- E. Холери

8. У дванадцятирічного пацієнта віком спостерігаються підвищення температури тіла до 39°C, кашель, утруднене дихання, біль у грудях і животі. Під час об'єктивного обстеження виявлено: втягнення міжреберних проміжків, роздування крил носа, тахіпное, тахікардія. Під час аускультативного легень вислуховуються локальні вологі дрібноміхурцеві хрипи, визначається приглушення перкуторного звуку, SaO₂ - 92%. Установіть попередній діагноз.

- A. Стороннє тіло дихальних шляхів
- B. Плеврит
- C. Гострий простий бронхіт
- D. Бронхіальна астма
- E. Пневмонія

9. Дитина народилася в терміні гестації 36 тижнів, з масою тіла 1900 г. Коли потрібно провести дитині вакцинацію проти туберкульозу?

- A. Через 48 год після народження незалежно від маси тіла
- B. Після того, як маса тіла дитини досягне 2200 г
- C. Після того, як маса тіла дитини досягне 2500 г
- D. Із двомісячного віку після негативної проби Манту незалежно від маси тіла
- E. Після того, як маса тіла дитини досягне 2000 г

10. У семирічної дитини діагностовано бронхіальну астму середнього ступеня тяжкості. З анамнезу відомо, що її бабуса також хворіє на це захворювання. Які препарати потрібно призначити для базисної терапії цього захворювання?

- A. Нестероїдні протизапальні
- B. Холінолітики
- C. Антибіотики
- D. beta₂-агоністи короткої дії
- E. Інгаляційні кортикостероїди в малих дозах

11. Дитина (вік - 9 місяців) попередньо нещеплена. Відхилень у стані здоров'я

дитини не виявлено, протипоказання до введення імунобіологічних препаратів відсутні. Оберіть оптимальну тактику стосовно профілактичного щеплення проти туберкульозу в цьому разі.

- A. Провести вакцинацію БЦЖ після позитивного результату проби Манту
- B. Негайно вакцинувати дитину вакциною БЦЖ
- C. Скерувати на консультацію до дитячого фтизіатра
- D. Щорічно проводити пробу Манту, оскільки вакцинація БЦЖ недоцільна
- E. Провести вакцинацію БЦЖ після негативного результату проби Манту

12. Тринадцятирічна пацієнтка скаржиться на слабкість, біль та набряк дрібних суглобів пальців рук, підвищення температури тіла до 37,9°C, появу висипу на шкірі обличчя. Під час об'єктивного обстеження на шкірі обличчя, щоках та крилах носа виявлено еритематозні плями у формі метелика, виразки в порожнині рота. Аускультативно: в легенях везикулярне дихання, тони серця приглушені, вислуховується шум тертя перикарду, ЧСС - 102/хв. Печінка виступає з-під краю реберної по середньоключичній лінії на 3 см. У периферичній крові: лейкоцити - $3,1 \cdot 10^9/\text{л}$. Установіть попередній діагноз.

- A. Ювенільний ідіопатичний артрит
- B. Реактивний артрит
- C. Системний червоний вовчак
- D. Ювенільний дерматоміозит
- E. Гостра ревматична гарячка

13. Тринадцятирічна пацієнтка після емоційних перенавантажень скаржиться на рецидивуючий абдомінальний біль без чіткої локалізації, різної інтенсивності, що зменшується, але не минає після дефекації і відходження газів та виникає 1-2 рази на тиждень, непостійний метеоризм, що посилюється протягом дня, переважно в нижніх відділах живота, чергування діареї і закрепів (діарея без поліфекалії, 2-4 рази на добу тільки в ранковий час після сніданку), відчуття неповного спорожнення кишечника. Під час об'єктивного обстеження відхилень не виявлено, фізичний, статевий розвиток та нутритивний статус відповідають віковим нормам. Отримано негативні результати тестів калу на приховану кров та серологічний скринінг на целіакію, С-реактивний білок у межах норми, загальний аналіз крові та сечі без

особливостей. Установіть попередній діагноз.

- A. Функціональна диспепсія
- B. Інфекційний ентероколіт
- C. Абдомінальна мігрень
- D. Виразкова хвороба (пептична виразка)
- E. Синдром подразненого кишківника за змішаним типом

14. Пацієнта віком 14 років шпиталізовано до лікарні з симптомами отруєння наркотичними речовинами. Вкажіть клінічні ознаки, що вказують на передозування опіоїдами.

- A. Біль у роті, горлі та грудях, що посилюється під час ковтання та дихання, гіперсалівація, нудота, блювання, діарея
- B. Порушення дихання (задишка, шумне дихання), зміна тембру голосу, кашель
- C. Відчуття 'піску' або різі в очах, світлобоязнь, опіки губ, язика або шкіри
- D. Пітливість, збудження, марення, м'язові посмикування, судоми, втрата свідомості
- E. Пригнічення дихання, артеріальна гіпотензія, значне звуження зіниць (міоз) та ослаблення їх реакції на світло, блідість шкіри, втрата свідомості

15. У дворічної дитини раптово під час вживання їжі з'явилися кашель та задишка. Хронічні хвороби в дитини батьки заперечують. З анамнезу відомо, що її рідний брат хворіє на atopічний дерматит. Дитина щеплена за віком згідно з Національним календарем профілактичних щеплень. Об'єктивно спостерігається: дитина неспокійна, температура тіла - 36,8°C, пульс - 128/хв, ЧД - 38/хв. Який патологічний стан, найімовірніше, розвинувся в дитини?

- A. Дифтерійний круп
- B. набряк Квінке
- C. Спонтанний пневмоторакс
- D. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт
- E. Обструкція дихальних шляхів стороннім тілом

16. Для зручності підрахунку кількості вуглеводів у їжі для пацієнтів, які хворіють на цукровий діабет, розроблена система хлібних одиниць (ХО). Скільки грамів вуглеводів містить 1 ХО?

- A. 18-20 г

B. 10-12 г

C. 5-6 г

D. 14-15 г

E. 7-8 г

17. У дев'ятирічного хлопчика спостерігаються підвищення температури тіла, зниження апетиту, млявість, біль у горлі, утруднення носового дихання. Під час об'єктивного обстеження виявлено: загальний стан середньої тяжкості, температура тіла - 38,4°C, шкіра чиста, бліда, шийні лімфовузли збільшені, спаяні в 'пакети', розміром до 2,5x2 см, під час пальпації помірно болючі, мигдалики гіпертрофовані, гіперемовані, з гнійними нальотами, печінка виступає з-під краю реберної дуги на 3 см, селезінка - на 1,5 см. Які лабораторні тести є доцільними для діагностики захворювання?

- A. РНА з комерційним дифтерійним антигеном (виявлення дифтерійного токсину у сироватці крові)
- B. Мазок із зів та носа на патогенну мікрофлору
- C. Виявлення в крові специфічних антитіл класу IgM до вірусу паротиту методом ІФА
- D. Виявлення антитіл до EBV NA IgG методом ІФА
- E. Виявлення антитіл до EBV CA Ig та/або до EA IgG методом ІФА

18. У дитини (вік - 6 місяців) під час вживання їжі раптово з'явилися кашель та стридорозне дихання. Об'єктивно спостерігається: дитина притомна, плаче, нападаючому гучно кашляє, робить паузу перед наступним вдихом. Укажіть перший етап невідкладної допомоги в цьому разі.

- A. Стимулювати дитину до кашлю та вести спостереження за нею
- B. Застосувати щипці Magill для видалення стороннього тіла з дихальних шляхів
- C. Увести десенсибілізуючі препарати
- D. Нанести 5 натискань двома пальцями на нижню частину груднини дитини
- E. Нанести до 5-ти різких ударів основою долоні між лопатками дитини

19. У восьмирічного хлопчика раптово підвищилася температура тіла до 39,5°C, розвинулися млявість, адинамія. Через декілька годин на шкірі сідниць, стегон, гомілок та нижній частині тулуба з'явився геморагічний висип зірчастої форми

діаметром 2-5 мм зі щільною інфільтрованою основою. Елементи висипу підвищуються над поверхнею шкіри та не зникають після натискання. Установіть попередній діагноз.

- A. Менінгококцемія
- B. Скарлатина
- C. Краснуха
- D. Кір
- E. Геморагічний васкуліт

20. Дворічного хлопчика, який хворіє на ГРВІ, шпиталізовано на 4-й день хвороби у зв'язку з різким погіршенням загального стану. Об'єктивно спостерігається: непродуктивний кашель, прогресуюча задишка, температура тіла - 37,8°C, пульс - 130/хв, ЧД - 56/хв, шкіра бліда, ретракції грудної клітки. Перкуторно над легень визначається коробковий звук. Під час аускультатії вислуховуються розсіяні сухі свистячі хрипи, у нижніх відділах легень - поодинокі дрібноміхурцеві хрипи, видих подовжений. Який найімовірніший діагноз?

- A. Пневмонія
- B. Стороннє тіло дихальних шляхів
- C. Гострий обструктивний бронхіт
- D. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт
- E. Дифтерія гортані

21. У новонародженої дитини (вік - 25 днів), яка народилася здоровою та перебуває на грудному вигодовуванні, спостерігаються жовтяниця, збільшення печінки, двостороння катаракта, судоми та блювання. Який найімовірніший діагноз?

- A. Вроджений токсоплазмоз
- B. Галактоземія
- C. Набута цитомегаловірусна інфекція
- D. Синдром вродженої краснухи
- E. Фетальний алкогольний синдром

22. Десятирічна дівчинка хворіє на бронхіальну астму. Діагноз вперше встановлено 3 місяці тому. На момент встановлення діагнозу такі симптоми, як кашель, утруднене та свистяче дихання виникали 6-7 разів на місяць. Дитині було призначено базисну терапію інгалаційними кортикостероїдами (будесонід) у низьких дозах щоденно, сальбутамол за потреби, а також були надані рекомендації з елімінаційних заходів щодо причинних алергенів. За останні 4 тижні симптоми астми вдень виникали тричі, нічні напади - один раз. Перебіг астми лікар інтерпретував як частково контрольований.

Укажіть найдоцільнішу подальшу тактику лікаря.

- A. Заміна будесоніду на інший інгалаційний глюкокортикостероїд
- B. Збільшення дози будесоніду до середньої
- C. Оцінювання техніки інгалації та прихильності пацієнта до терапії
- D. -
- E. Додавання до терапії антилейкотрієнового препарату

23. У дитини (вік - 8 місяців) спостерігаються підвищення температури тіла до 38,5°C, неспокій, втрата апетиту, рідкі випорожнення. Тяжкість стану зумовлена симптомами інтоксикації. Під час об'єктивного обстеження виявлено: дихання в легенях пуерильне, хрипів немає, ЧСС - 150/хв, ЧД - 42/хв, живіт помірно здутий. Випорожнення рідкі, жовтого кольору, 3 рази на добу. Діурез достатній. У периферичній крові: лейкоцити - $25 \cdot 10^9/\text{л}$, ШОЕ - 47 мм/год. Проба сечі на нітрити - позитивна. Який найімовірніший діагноз?

- A. Інвагінація кишківника
- B. Гострий гломерулонефрит
- C. Гострий гастроентерит
- D. Гострий пієлонефрит
- E. Гостра кишкова інфекція

24. У восьмирічного хлопчика захворювання розпочалося гостро, з підвищення температури тіла, загальної слабкості, головного болю та болю у горлі під час ковтання. На 3-й день хвороби об'єктивно спостерігається: температура тіла - 38,8°C, збільшення задньошийних та передньошийних лімфатичних вузлів, на шкірі та видимих слизових оболонках виявлено нерясний плямисто-папульозний висип, піднебінні мигдалики гіперемовані, набряклі, з білувато-жовтим нальотом, що легко знімається шпателем, гепатоспленомегалія. Результати клінічного аналізу крові: лейкоцити - $14 \cdot 10^9/\text{л}$, еозинофіли - 1%, паличкоядерні нейтрофіли - 4%, сегментоядерні нейтрофіли - 22%, лімфоцити - 52%, моноцити - 8%, атипові мононуклеари - 13%, ШОЕ - 20 мм/год. Для якого захворювання характерні ці клініко-лабораторні показники?

- A. Інфекційного мононуклеозу
- B. Епідемічного паротиту
- C. Хвороби Годжкіна

- D. Стрептококового тонзиліту
- E. Токсичної дифтерії ротоглотки

25. У пацієнтки віком 15 років виникла серія генералізованих тоніко-клонічних судом, що тривала понад 30 хв. Під час нападу судом відбулося прикушування язика, спостерігалися порушення дихання, виділення піни з рота, мимовільне сечовипускання. Пацієнтка без свідомості. Який патологічний стан розвинувся в пацієнтки?

- A. Гіпоглікемічна кома
- B. Епілептичний статус
- C. Спазмофілія
- D. Гострий психоз
- E. Неврогенний синкопальний стан

26. Семирічного хлопчика шпиталізовано до лікарні з болем у животі. З анамнезу відомо, що біль у животі вперше виник близько місяця тому після перенесеного бактеріального тонзиліту, наростав у динаміці, погіршувався загальний стан, з приводу чого проведено апендектомію, проте біль у животі тривав і після операції. Об'єктивно спостерігається: виражений інтоксикаційний синдром, у ділянці обох гомілковостопних суглобів на тлі гіперемованої шкіри виявляються численні елементи папульозно-геморагічного висипу. Периферичні лімфовузли дрібні, рухливі, безболісні. Живіт м'який, пальпаторно болючий, біль без чіткої локалізації, печінка та селезінка не пальпуються. Випорожнення оформлені, звичайного кольору. Менінгеальних симптомів не виявлено. Установіть попередній діагноз.

- A. Вузликовий періартеріїт
- B. Ювенільний ідіопатичний артрит
- C. Хвороба Шенляйн-Геноха, змішана форма
- D. Хвороба Шенляйн-Геноха, шкірна форма
- E. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура

27. У п'ятирічної дитини спостерігаються м'язова слабкість протягом останніх 3-х місяців. Їй важко підійматися сходами, бігати та гратися. Батьки також помітили, що у неї з'явився висип на обличчі та руках, підвищується температура тіла до 38°C протягом останніх 2-х днів. Під час фізикального обстеження виявлено висип на обличчі, плечах та спині (симптом 'шалі'), м'язову слабкість проксимальних груп м'язів. Встановлено діагноз:

ювенільний дерматоміозит. Укажіть найефективнішу терапевтичну тактику для лікування цього захворювання.

- A. Системна кортикостероїдна терапія
- B. Антибіотикотерапія
- C. Дієтичне харчування
- D. Імуносупресивна терапія
- E. Фізіотерапія

28. Яка з нижченаведених груп препаратів використовується для проведення пробної терапії бронхіальної астми у дітей, молодших за п'ять років?

- A. Системні кортикостероїди
- B. Блокатори H1-рецепторів гістаміну
- C. Пролонговані beta₂-агоністи
- D. Інгаляційні кортикостероїди
- E. Антилейкотрієнові препарати

29. У шестирічної дитини, яка хворіє на цукровий діабет 1-го типу, після ін'єкції інсуліну з'явилися запаморочення, холодний піт, тремор пальців рук, порушення зору. Через декілька хвилин дитина втратила свідомість. Який лікарський засіб потрібно негайно ввести дитині для надання невідкладної допомоги?

- A. Інсулін 10-12 ОД внутрішньовенно
- B. Інсулін 1 ОД/кг маси тіла підшкірно
- C. 4%-й розчин натрію гідрокарбонату 20 мл внутрішньовенно
- D. Ізотонічний розчин натрію хлориду 40 мл внутрішньовенно
- E. 40%-й розчин глюкози внутрішньовенно струминно (20-40 мл)

30. У передчасно народженої дівчинки в терміні гестації 32 тижні через 4 год після народження розвинулися симптоми дихальної недостатності, що наростають у динаміці, спостерігається участь в акті дихання додаткових м'язів, роздування крил носа. Аускультативно: дихання різко ослаблене. За результатами рентгенологічного дослідження виявлено значне зниження пневматизації, тінь серця майже не контурується. Яка патологія зумовила розвиток дихальних розладів у дитини?

- A. Респіраторний дистрес-синдром
- B. Вроджена пневмонія
- C. Ателектази легень
- D. Аспіраційний синдром
- E. Внутрішньоутробна інфекція

31. Одинадцятирічній дівчинці встановлено попередній діагноз: системний червоний вовчак. Укажіть ключове лабораторне дослідження для підтвердження цього діагнозу.

- A. Визначення рівня глюкози в крові та сечі
- B. Виявлення антитіл до дволанцюгової ДНК
- C. Визначення рівня ревматоїдного фактора
- D. -
- E. Встановлення концентрації сечової кислоти в крові

32. У шестирічного хлопчика спостерігаються такі симптоми: диспное (задишка), збільшення частоти дихання ($>30-35/\text{хв}$), участь в акті дихання допоміжної мускулатури, тахікардія (пульс - $100/\text{хв}$), ціаноз губ та шкіри пальців рук, надмірна пітливість, нудота, дитина збуджена, налякана. Інформації щодо попередніх захворювань чи травм у дитини немає. Результати газового аналізу крові: PaO_2 - 52 мм рт. ст., SaO_2 - 83%. Який патологічний стан розвинувся в дитини?

- A. Гостра лівошлуночкова серцева недостатність
- B. Дихальна недостатність I ступеня
- C. Дихальна недостатність II ступеня
- D. Гостра судинна недостатність
- E. Дихальна недостатність III ступеня

33. У восьмирічної дитини спостерігаються тривалий субфебрилітет, загальна слабкість, головний біль, міалгія, артралгія. Під час об'єктивного обстеження виявлено збільшення шийних лімфатичних вузлів, печінки та селезінки. З анамнезу відомо, що дитині 3 тижні тому подарували кошеня. Виявлення і наростання титру яких антитіл спостерігатиметься в цьому разі?

- A. IgM та G до *emphBrucella melitensis*
- B. IgM та G до *emphBartonella bacilliformis*
- C. IgM та G до *emphBorrelia burgdorferi*
- D. IgM та G до *emphBrucella canis*
- E. IgM та G до *emphToxoplasma Gondii*

34. У дванадцятирічної пацієнтки спостерігаються загальна слабкість, спотворення нюху і смаку, виразки та тріщини в кутах рота. Під час фізикального обстеження виявлено: лімфатичні вузли не збільшені, печінка та селезінка не пальпуються. У периферичній крові: еритроцити - $3,2 \cdot 10^{12}/\text{л}$, гемоглобін - 82

г/л, КП - 0,6, лейкоцити - $4,6 \cdot 10^9/\text{л}$, тромбоцити - $190 \cdot 10^9/\text{л}$. Установіть попередній діагноз.

- A. Гострий лейкоз
- B. Інфекційний моноклеоз
- C. Залізодефіцитна анемія
- D. Апластична анемія
- E. Гемолітична анемія

35. Мати чотирирічного хлопчика протягом останніх 7-ми тижнів помічає в дитини періодичну кульгавість, набряк обох колінних суглобів, ранкову скутість. Останні 2,5 тижні один раз на день увечері виникала гарячка, що супроводжувалася появою дрібнопапульозного висипу, який зникав після зниження температури тіла. Під час об'єктивного обстеження виявлено спленомегалію, двостороннє запалення ліктьових і колінних суглобів. Згодом у дитини розвинувся синдром гіперактивації макрофагів. Яке захворювання спричинило розвиток цього синдрому?

- A. Хвороба Кавасаки
- B. Ювенільний дерматоміозит
- C. Системний ювенільний ідіопатичний артрит
- D. Ювенільний ідіопатичний артрит
- E. Системний червоний вовчак

36. У п'ятирічної дитини раптово виникли нудота, блювання, підвищилася температура тіла, спостерігаються іктеричність та свербіж шкіри, сонливість, з'явився запах ацетону з рота. Під час збору анамнезу з'ясувалося, що у зв'язку з гіпертермією дитина приймала високі дози нестероїдних протизапальних препаратів. Під час об'єктивного обстеження виявлено: оглушеність, геморагічний синдром (петехії на шкірі), долонна еритема. За результатами лабораторного дослідження виявлено гіпербілірубінемію за рахунок прямої фракції, азотемію, зниження ПТГ, рівня холестерину та глюкози, підвищення активності аміотрансфераз та лужної фосфатази. Який патологічний стан розвинувся в дитини?

- A. Вірусний гепатит A
- B. Синдром холестазу
- C. Гостра ниркова недостатність
- D. Гіпоглікемічна кома
- E. Гостра печінкова недостатність

37. Укажіть пріоритетний препарат для лікування стабільної суправентрикулярної тахікардії у дітей.

A. Аденосин-трифосфат (АТФ)

B. Лідокаїн

C. Адреналін

D. Аміодарон

E. Магнію сульфат

38. Укажіть антибіотик першої лінії, що використовується для лікування позалікарняної пневмонії як у дітей, так і в дорослих пацієнтів.

A. Цефтріаксон

B. Амоксицилін

C. Кларитроміцин

D. Левофлоксацин

E. Азитроміцин

39. У трирічної дитини спостерігаються підвищення температури тіла до 39,5°C, загальне нездужання, головний біль. Укажіть препарат першої лінії для лікування гарячки в дитини на догоспітальному етапі.

A. Димедрол

B. Парацетамол

C. Транексамова кислота

D. Диклофенак натрію

E. Ацетилсаліцилова кислота

40. У восьмирічного хлопчика спостерігаються такі особливості випорожнень: відбуваються 2 рази на тиждень і рідше, калові маси великого діаметру та тверді, біль під час акту дефекації, що минає після його завершення. З анамнезу відомо, що подібні клінічні прояви з'явилися із семирічного віку після початку відвідування школи. У харчовому раціоні переважає борошняна їжа. Під час об'єктивного обстеження патології з боку внутрішніх органів не виявлено. Результати ректального дослідження: ректальні мікротріщини та наявність великих калових мас у прямій кишці. Фізичний, статевий розвиток та нутритивний статус відповідають віковим нормам. С-реактивний білок у межах норми, загальний аналіз крові та сечі без особливостей. Який патологічний стан розвинувся в дитини?

A. Абдомінальна мігрень

B. Хвороба Гіршпрунга

C. Синдром подразненого кишечника з закрепом

D. Функціональна диспепсія

E. Функціональний закреп

41. У семирічної дитини захворювання розпочалося гостро, із симптомів

інтоксикації та серозного запалення слизових оболонок. Об'єктивно спостерігається: температури тіла - 38,7°C, рясний плямисто-папульозний висип на шкірі, місцями зливається, розміщується на незмінній шкірі. Висип спочатку з'явився на обличчі, потім поширився на грудну клітку, далі - на нижні кінцівки. Периферичні лімфовузли не значно збільшені, чутливі під час пальпації. Установіть попередній діагноз.

A. Псевдотуберкульоз

B. Вітряна віспа

C. Краснуха

D. Скарлатина

E. Кір

42. У новонародженої дитини (вік - 10 днів), яка народилася у терміні гестації 42 тижні з масою тіла 4500 г, спостерігаються млявість, іктеричність шкіри, набряк обличчя, повік, губ, кистей і стоп, макроглісія, низький тембр голосу під час плачу. Концентрація тиреотропного гормону в сироватці крові - 42 мОД/л. Який препарат потрібно призначити для лікування дитини?

A. Калію йодид

B. Левотироксин

C. Фуросемід

D. Мерказоліл

E. Преднізолон

43. Семирічного хлопчика впродовж останніх 2-х місяців турбують пароксизмальний кашель, задишка під час фізичних навантажень, відчуття стиснення в грудній клітці. В анамнезі: екзема, 3 епізоди інфекції верхніх дихальних шляхів без ускладнень і 1 епізод гострого середнього отиту, що лікувався антибіотиками. Об'єктивно спостерігається: температура тіла - 37,2°C, пульс - 120/хв, ЧД - 28/хв, АТ - 90/60 мм рт. ст., аускультативно в легенях вислуховуються різнокаліберні хрипи. Яке дослідження найдоцільніше насамперед провести дитині під час первинного обстеження?

A. УЗД легень

B. Проточну цитометрію В-клітин

C. Визначення рівня IgA в сироватці крові

D. КТ органів грудної клітки

E. Співометрію

44. Дитина народилася від першої вагітності, що проходила на тлі ускладнення - ризику переривання

впродовж всієї вагітності, у терміні гестації 38-39 тижнів. Оцінка за шкалою Апгар - 4-5 балів, маса тіла при народженні - 3070 г, довжина тіла - 53 см, ЧСС - 90/хв. Проводилися реанімаційні заходи. Стан дитини стабілізувався. Який лікарський засіб потрібно призначити дитині, як післяреанімаційну терапію?

- A. 10%-й розчин глюкози 10 г/кг/добу в/в
- B. Реополиглюкін 5-10 мл/кг в/в
- C. 5%-й розчин глюкози 6 г/кг/добу в/в або empher os
- D. Фізіологічний розчин 10 мг/кг в/в або в/к
- E. Фізіологічний розчин 30 мг/кг в/в або в/к

45. Дитині (вік - 1 рік 4 місяці) діагностовано гострий обструктивний бронхіт. Хвороба погано піддається лікуванню. З анамнезу відомо, що до однорічного віку дитина двічі перехворіла на пневмонію, ускладнену обструктивним синдромом. Спостерігаються хронічна стеаторея, рясне потовиділення, рецидивуючий кашель. Під час лабораторного дослідження виявлено підвищення рівня хлоридів поту - 98 ммоль/л, рівень амілази крові знижений, в копрограмі - велика кількість нейтрального жиру. Яке додаткове дослідження доцільно призначити дитині насамперед для уточнення діагнозу?

- A. Молекулярну діагностику муковісцидозу
- B. Виявлення антигліадинових антитіл у крові
- C. Визначення рівня імуноглобулінів сироватки крові
- D. Колоноскопію
- E. Вимірювання електролітів сироватки крові

46. У дитини (вік - 6 місяців) спостерігаються підвищення температури тіла до субфебрильних цифр та рясні часті водянисті випорожнення. Під час об'єктивного обстеження виявлено: дитина млява, температура тіла - 37,2°C, сухість слизових оболонок, зниження тургору тканин, олігурія, пульс слабого наповнення, ЧСС - 140/хв, ЧД - 28/хв. Результати лабораторного дослідження: гематокрит - 0,56, Na^{++} - 158 ммоль/л, K^{++} - 3,0 ммоль/л. Визначте тип ексикозу.

- A. Гіпертонічний (вододефіцитний)
- B. Ізотонічний із гіпокаліємією
- C. Ізотонічний із гіперкаліємією

- D. Змішаний із нормокаліємією
- E. Гіпотонічний (соледефіцитний)

47. Яка методика реабілітації у немовлят із високим ризиком формування церебрального паралічу має доведену ефективність?

- A. Гідрокінезіотерапія
- B. Медикаментозна терапія (ноотропна, нейрометаболітна)
- C. Масаж
- D. Пасивні методики рухової терапії
- E. Тренування рухових навичок

48. Пацієнту з діагнозом: епілепсія, призначено протисудомну терапію. Неєфективна терапія якою кількістю протисудомних препаратів вказує на те, що епілепсія є фармакорезистентною?

- A. П'ятьма
- B. Чотирма
- C. Трьома
- D. Двома
- E. Шістьма

49. У чотирирічної дівчинки раптово підвищилася температура тіла до 38,5°C, з'явилися слизові виділення з носа, покашлювання, одноразове блювання, рідкі випорожнення. З анамнезу відомо, що дитина не вакцинована. Через 2 дні стан дитини різко погіршився, з'явився біль у нижніх та верхніх кінцівках, хребті, особливо під час спроби сісти. Об'єктивно спостерігається: обмеження рухів, неможливість стояти, зниження тону м'язів, відсутність сухожильних рефлексів на нижніх кінцівках, особливо в проксимальних ділянках, чутливість збережена. Попередній діагноз: поліомієліт. Укажіть форму поліомієліту.

- A. Абортівна
- B. Понтинна
- C. Менінгеальна
- D. Спінальна
- E. Бульбарна

50. У трирічного хлопчика захворювання розпочалося гостро, з підвищення температури тіла до 37,3°C та появи висипу на шкірі. Об'єктивно спостерігається: помірна гіперемія зів та дрібний блідо-рожевий плямисто-папульозний висип на шкірі. Спочатку висип з'явився на обличчі, а протягом декількох годин без етапності швидко поширився на весь тулуб, тенденції до злиття немає. Одночасно з появою висипу на шкірі з'явилася енантема на

слизовій оболонці м'якого піднебіння у вигляді дрібних блідо-рожевих плям. Пальпуються збільшені потиличні та задньовийні лімфатичні вузли. Який найімовірніший діагноз?

- A. Краснуха
- B. Псевдотуберкульоз
- C. Вітряна віспа
- D. Скарлатина
- E. Кір

51. П'ятирічного хлопчика вжалила бджола. Через 10 хв з'явилися еритема, печіння та свербіж шкіри, відчуття стискання в глотці та грудях, кашель, захриплість голосу, свистяче дихання, сплутаність свідомості, пітливість. АТ - 70/30 мм рт. ст. Який патологічний стан розвинувся в дитини?

- A. набряк Квінке
- B. Кропив'янка
- C. Анафілактичний шок
- D. Септичний шок
- E. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

52. У трирічної дитини на 5-й день захворювання спостерігаються такі симптоми: підвищення температури тіла до 38,7°C, виражена слабкість, першіння у горлі, нежить, головний біль, відсутність активних рухів у ногах, неможливість стояти та ходити. Під час об'єктивного обстеження виявлено: блідість шкірних покривів, гіперемія зів, нижні кінцівки холодні на дотик, гіперестезія, позитивні симптоми натягу, сидить у позі 'триноги', пасивні рухи в ногах у повному об'ємі, поверхнева та глибока чутливість збережені. Аускультативно над легеньми вислуховується везикулярне дихання, ЧД - 28/хв, тони серця ослаблені, ЧСС - 115/хв. Живіт м'який, безболісний. Випорожнення 3 рази на добу, кашкоподібні, містять домішки неперетравленої їжі. Установіть попередній діагноз.

- A. ГРВІ, ринофарингіт
- B. Міастенія
- C. Поліомієліт
- D. Вірусний енцефаліт
- E. Ентеровірусна інфекція, герпангіна

53. У чотирирічного хлопчика впродовж останніх 3-х місяців періодично виникають напади задишки та непродуктивного кашлю, здебільшого вночі, іноді такі напади виникають під час розваг. З анамнезу відомо, що в дитини алергія на арахіс, а в його матері діагностовано

алергічний риніт. Аускультативно над легеньми вислуховуються розсіяні сухі свистячі хрипи з обох боків. На рентгенограмі органів грудної клітки відхилень не виявлено. Установіть попередній діагноз.

- A. Муковісцидоз
- B. Обструкція дихальних шляхів стороннім тілом
- C. Бронхіальна астма
- D. Гострий бронхіоліт
- E. Спонтанний пневмоторакс

54. Дев'ятирічна дитина скаржиться на періодичний біль в епігастральній ділянці, відрижку повітрям та відчуття тяжкості в животі після їжі. Вказані скарги з'являються 1-2 рази на тиждень протягом останніх 4-х місяців. Порушень випорожнень немає. Дитина часто вживає солодощі, снеки, газовані напої. Об'єктивно спостерігається: вага та зріст дитини відповідають віковим нормам, температура тіла - 36,6°C, під час пальпації живіт дещо здутий, чутливий в епігастрії, печінка не збільшена. Інші органи та системи без особливостей. Результати загального аналізу крові: еритроцити - $4,5 \cdot 10^{12}/л$, гемоглобін - 142 г/л, лейкоцити - $5,4 \cdot 10^9/л$, паличкоядерні нейтрофіли - 2%, сегментоядерні нейтрофіли - 58%, еозинофіли - 3%, лімфоцити - 30%, моноцити - 7%, ШОЕ - 6 мм/год. Аналізи калу на яйця гельмінтів, антигени *emphN*, *pylori* та лямблій, приховану кров - негативні. Результати ФЕГДС: слизова оболонка стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки не змінена, у шлунку наявна невелика кількість жовчі. Який найімовірніший діагноз?

- A. Функціональна диспепсія
- B. Синдром подразненого кишківника
- C. Хронічний гастродуоденіт
- D. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба
- E. Абдомінальна мігрень

55. У чотирирічного хлопчика спостерігаються підвищення температури тіла до 39°C, багаторазове блювання та діарея. Дитина млява, відмовляється від пиття. За результатами лабораторного дослідження виявлено: гематокрит - 0,56, Na^{+} - 119 ммоль/л, K^{+} - 5,8 ммоль/л. Які порушення водно-електролітного балансу спостерігаються в дитини?

- A. Гіпотонічна дегідратація, гіпокаліємія
- B. Ізотонічна дегідратація, гіперкаліємія

С. порушення водно-електролітного балансу відсутні

Д. Гіпернатріємічна дегідратація

Е. Гіпотонічна дегідратація, гіперкаліємія

56. У новонародженого хлопчика виявлено трисомію за 21-ю хромосомою. Через 6 год після народження з'явилося блювання з домішками жовчі, що посилюється під час годування. Дитина народилася в передбачений термін шляхом фізіологічних пологів, з масою тіла - 3050 г. Під час огляду живота виявлено, що ділянка епігастрія роздута, а низ живота запалий. Установіть попередній діагноз.

А. Атрезія тонкої кишки

В. Хвороба Гіршпрунга

С. Меконіальний ілеус

Д. Атрезія дванадцятипалої кишки

Е. Гіпертрофічний пілоростеноз

57. У шестирічного хлопчика впродовж останніх 8-ми днів спостерігається біль та набряк лівого колінного суглоба, періодично підвищується температура тіла та з'являється біль у м'язах. З анамнезу відомо, що близько 2-х місяців тому, через 2 тижні після прогулянки в лісі, на шкірі лівого стегна з'явилася локальна яскраво-червона пляма, що повільно збільшувалася в розмірах та самостійно зникла через 2 тижні. Яке дослідження має діагностичне значення в цьому разі?

А. Визначення швидкості осідання еритроцитів

В. Дослідження ревматоїдного фактора в сироватці крові

С. Аналіз сироваткових антинуклеарних антитіл

Д. Рентгенографія органів грудної клітки

Е. Аналіз сироваткових антитіл до *Borrelia burgdorferi*

58. У п'ятирічної дитини спостерігаються підвищення температури тіла до 38°C, біль та першіння в горлі, збільшення підщелепних лімфовузлів, поява білого нальоту на піднебінних мигдаликах, що легко знімається шпателем, кашлю немає. Установіть попередній діагноз.

А. Дифтерія

В. Гострий тонзиліт

С. Паратонзиллярний абсцес

Д. Епіглотит

Е. Інфекційний мононуклеоз

59. Лікар-педіатр інформує батьків шестирічного хлопчика про заплановані щеплення. З анамнезу відомо, що 1 рік тому дитина перехворіла на локалізовану форму дифтерії ротоглотки. Наразі протипоказання до введення імунобіологічних препаратів у дитини відсутні. Введення яких вакцин доцільне в цьому разі?

А. КПК, ОПВ та дифтерійно-правцевого анатоксину

В. Відтермінувати вакцинацію на 5 років

С. КПК та ОПВ

Д. КПК, ОПВ та правцевого анатоксину

Е. Коклюшно-дифтерійно-правцевої вакцини

60. У чотирирічного хлопчика діагностовано вітряну віспу (1-й день хвороби). Чи доцільно провести специфічну імунопрофілактику його сестрі (вік 1 рік і 2 місяці), яка проживає разом із ним в осередку інфекції, ще не хворіла і не щеплена проти цього інфекційного захворювання?

А. Ні, вакцинопрофілактику необхідно провести заздалегідь

В. Так, вакцинопрофілактика ефективна впродовж місяця від моменту контакту з хворим на вітряну віспу

С. Так, вакцинопрофілактика ефективна впродовж 3-х днів від моменту контакту з хворим на вітряну віспу

Д. Так, застосовується профілактичне призначення ацикловіру

Е. Ні, вакцина проти вітряної віспи заборонена в цьому віці

61. У восьмирічної дитини захворювання розпочалося поступово, спостерігаються підвищення температури тіла до 38,0°C, рясні слизові виділення з носа, вологий кашель. Під час об'єктивного обстеження виявлено: слизова оболонка ротоглотки гіперемована, мигдалики та передні дужки набрякли, пливчастий лівобічний кон'юнктивіт, незначне збільшення підщелепних, шийних, пахвинних та пахових лімфовузлів, гепатомегалія, селезінка пальпується біля краю ребра. Для якого захворювання характерні ці клінічні прояви?

А. Грипу

В. Інфекційного мононуклеозу

С. Дифтерії

Д. Парагрипу

Е. Аденовірусної інфекції

62. У немовляти (вік - 2 місяці) спостерігаються напади раптового плачу і рухового занепокоєння (переважно ввечері та вночі), що тривають 3-4 год на добу, виникають не менше 3-х разів на тиждень упродовж 3-х тижнів поспіль. Дитина на грудному вигодовуванні, добре набирає вагу, розвивається за віком. Під час фізикального обстеження відхилень не виявлено. Укажіть найдоцільнішу тактику в догляді за дитиною.

- A. Призначити фототерапію
- B. Перевести дитину на штучне вигодовування
- C. Призначити антацидні засоби на ніч
- D. Проаналізувати календар щеплень
- E. Проінформувати батьків про період кишкових колік у новонародженого

63. Трирічну дитину шпиталізовано до приймального відділення з порушенням дихання. Об'єктивно спостерігається: дитина збуджена, шкірні покриви бліді та вологі, ЧД - 44/хв, пульс слабкого наповнення, ЧСС - 190/хв, АТ - 70/40 мм рт. ст. На ЕКГ: регулярна тахікардія з широкими комплексами QRS, частотою - 192/хв, дискордантні зміни сегменту ST і зубця T, відсутність зубців P. Цей стан розвинувся в дитини раптово, близько 20-ти хв тому. Оберіть найдоцільнішу тактику для надання невідкладної допомоги дитині.

- A. Проведення дефібриляції
- B. Синхронізована електрична кардіоверсія
- C. Черезшкірна електрокардіостимуляція
- D. Проведення вагусних проб
- E. Внутрішньовенне введення верапамілу

64. Пацієнтка віком 15 років скаржиться на підвищену втомлюваність, періодичне здуття та дискомфорт у животі після їжі, водянисті випорожнення з неприємним запахом та втрату маси тіла до 7 кг упродовж 8-ми місяців. 3 дні тому виник свербіж нижніх кінцівок. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, виявлено декілька напружених, екскоріованих везикул на обох колінних суглобах. Живіт м'який, безболісний. У загальному аналізі крові концентрація гемоглобіну становить 82 г/л, а середній об'єм еритроцитів - 76 фл. Які результати лабораторного дослідження можна очікувати під час подальшого обстеження пацієнтки?

- A. Підвищення панкреатичної еластази в калі

- B. Позитивний водневий дихальний тест
- C. Підвищений рівень амілази в крові
- D. Позитивний тест на приховану кров у калі

E. Антитіла IgA до тканинної трансглютамінази

65. Одинадцятирічного пацієнта шпиталізовано до лікарні. З анамнезу відомо, що 2,5 місяці тому він перехворів на скарлатину, отримувач антибактеріальну терапію. Незабаром мати дитини помітила в нього посмикування лицевої мускулатури, зміни почерку, неточність рухів під час одягання та вживання їжі, періодичне підвищення температури тіла до субфебрильних цифр, катаральних проявів не спостерігалось. Згодом неврологічні розлади наростали: посилилися прояви гримасування, хлопчик не може самостійно одягнутися, іноді з'являється потреба в допомозі під час їжі, зберігається плаксивість і дратівливість. Об'єктивно спостерігається: загальний стан тяжкий, неточне виконання координаційних рухів, м'язова гіпотонія, скандоване мовлення. Аускультативно: дихання везикулярне, хрипів немає. Грудна клітка в ділянці серця не деформована. Межі серця: права - праворуч груднини, верхня - по III ребру, ліва - на 1 см до середини від середньоключичної лінії. Тони серця помірно ослаблені, вислуховується негрубий систолічний шум на верхівці серця, що займає 1/6 систоли, не проводиться за межі ділянки серця, в ортостазі його інтенсивність зменшується. Живіт м'який, печінка та селезінка не збільшені. Результати загального аналізу крові: еритроцити - $4,5 \cdot 10^{12}/л$, гемоглобін - 120 г/л, лейкоцити - $6,5 \cdot 10^9/л$, еозинофіли - 2%, паличкоядерні нейтрофіли - 2%, сегментоядерні нейтрофіли - 46%, лімфоцити - 48%, моноцити - 2%, ШОЕ - 10 мм/год. Результати загального аналізу сечі: відносна щільність сечі - 1018, білка, глюкози та еритроцитів не виявлено, лейкоцити - 2-3 в п/з. Установіть попередній діагноз.

- A. Синдром Туретта
- B. Хорея Гентінгтона
- C. Неревматичний міокардит, кардіосклероз
- D. Транзиторний тиковий розлад
- E. Гостра ревматична гарячка, хорея

66. Під час огляду та обстеження немовляти (вік - 4 місяці) виявлено:

серцевий горб, верхівковий поштовх зміщений вліво і вниз. Пальпаторно: систолічне тремтіння в III-VI міжребер'ї ліворуч. Перкуторно: межі серцевої тупості розширені в поперечнику, більше вліво. Аускультативно: акцент II тону в II міжребер'ї ліворуч і його розщеплення, грубий пансистолічний шум у III-VI міжребер'ї ліворуч. На ЕКГ: ознаки бівентрикулярної гіпертрофії. На рентгенограмі органів грудної клітки: посилення легеневого малюнка, талія серця згладжена, обидва шлуночка дилатовані, випинає дуга легеневої артерії. Який найімовірніший діагноз?

- A. Відкрита артеріальна протока
- B. Дефект міжпередсердної перетинки
- C. Дефект у м'язовій частині міжшлуночкової перетинки
- D. Дефект у мембранозній частині міжшлуночкової перетинки
- E. Транспозиція магістральних судин

67. Який параметр використовується для діагностики стадії хронічної ниркової недостатності у дітей?

- A. Концентрація креатиніну в сироватці крові
- B. Рівень сироваткового калію
- C. Концентрація сечовини в сироватці крові
- D. Швидкість клубочкової фільтрації
- E. Концентрація креатиніну в сечі

68. Дванадцятирічний пацієнтці встановлено діагноз: персистуюча бронхіальна астма. Який тест використовується для контролю бронхіальної гіперреактивності в домашніх умовах?

- A. Нейросонографія
- B. Спірографія
- C. Пневмотахометрія
- D. Велоергометрія
- E. Пікфлоуметрія

69. У новонародженої дитини на початку 3-ї доби життя шкіра набула жовтого кольору. Дитина народилася від першої вагітності, перших пологів, з масою тіла - 3900 г, довжиною тіла - 55 см, перебуває на грудному вигодовуванні. Об'єктивно спостерігається: дитина активна, ЧД - 40/хв, аускультативно над легеньми вислуховується пuerильне дихання, тони серця ритмічні, ЧСС - 142/хв, живіт м'який, печінка виступає з-під краю реберної дуги

на 1,5 см, селезінка не пальпується. Колір сечі і калу не змінився. Який найімовірніший діагноз?

- A. Сепсис новонароджених
- B. Фізіологічна жовтяниця
- C. Пролонгована жовтяниця
- D. Гемолітична хвороба новонароджених
- E. Атрезія жовчних шляхів

70. Присутність якого спеціаліста обов'язкова під час ведення передчасних пологів або діагностованій затримці внутрішньоутробного росту плода для надання допомоги новонародженій дитині в пологовій залі?

- A. Лікаря-неонатолога
- B. Лікаря акушера-гінеколога
- C. Лікаря з медицини невідкладних станів
- D. Акушерки
- E. Лікаря-педіатра

71. У новонародженої дитини (вік - 14 днів) спостерігаються млявість, зригування, періодичне блювання, що не пов'язане з годуванням. Під час об'єктивного обстеження виявлено: макрогонітосомія, пігментація сосків та зовнішніх статевих органів, землист-сірий колір шкіри з мармуровим відтінком, тургор та еластичність шкіри знижені. Результати біохімічного аналізу крові: рівень 17-гідрооксипрогестерону підвищений, Na^{+} - 125 мекв/л, K^{+} - 6,2 мекв/л. На ЕКГ: загострення зубців Т. Який попередній діагноз?

- A. Вроджена гіперплазія кори надниркових залоз, проста вірильна форма
- B. Целиакія
- C. Вроджена гіперплазія кори надниркових залоз, сільутратна форма
- D. Лактазна недостатність
- E. Гостра кишкова інфекція

72. Із якою метою антилейкотрієнові препарати (монтелукаст) застосовуються як монотерапія у дітей, хворих на бронхіальну астму?

- A. У разі середньотяжкого перебігу бронхіальної астми
- B. Для надання невідкладної допомоги під час легкого нападу бронхіальної астми
- C. Як альтернатива інгаляційним глюкокортикостероїдам у лікуванні легкої персистуючої бронхіальної астми

- D. Для надання невідкладної допомоги під час тяжкого нападу бронхіальної астми
- E. У разі тяжкого перебігу бронхіальної астми

73. У немовляти (вік - 6 тижнів) з перших днів захворювання спостерігаються підвищення температури тіла, закладеність носа, чхання та сухий кашель. На 3-й день хвороби приєдналися симптоми дихальної недостатності. Під час об'єктивного обстеження виявлено: температура тіла - 37,9°C, ЧД - 64/хв, SaO₂ - 92%. Під час аускультативного легень вислуховується велика кількість вологих і сухих хрипів. Який збудник найчастіше спричиняє захворювання, що має такі клінічні прояви?

- A. Респіраторно-синцитіальний вірус
- B. Вірус парагрипу
- C. Аденовірус
- D. Пневмокок
- E. Вірус грипу типу А

74. У трирічної дитини, яка хворіє на гостру кишкову інфекцію, починаючи з 3-го дня хвороби погіршився загальний стан, з'явилися млявість, блідість та іктеричність шкіри, набряки та зниження діурезу. Аускультативно над легеньми вислуховується жорстке дихання, хрипів немає. Тони серця ослаблені, ритмічні, пульс - 100/хв. Живіт м'який, безболісний, гепатомегалія, селезінка не пальпується. Випорожнення рідкі, з прожилками крові. Результати загального аналізу крові: еритроцити - $3,5 \cdot 10^{12}/л$, гемоглобін - 100 г/л, ретикулоцити - 8%, тромбоцити - $70 \cdot 10^9/л$, лейкоцити - $15,7 \cdot 10^9/л$, паличкоядерні нейтрофіли - 2%, сегментоядерні нейтрофіли - 70%, лімфоцити - 19%, моноцити - 9%, ШОЕ - 25 мм/год. Результати загального аналізу сечі: кількість - 20 мл, колір - темно-коричневий, відносна щільність - 1,008, білок - 0,66 г/л, лейкоцити - 4-6 в п/з, еритроцити - до 100 в п/з. Результати біохімічного аналізу крові: загальний білок - 68 г/л, СРБ - 32 мг/л, загальний білірубін - 40 мкмоль/л, холестерин - 4,7 ммоль/л, сечовина - 38,6 ммоль/л, креатинін - 673 мкмоль/л, кліренс ендогенного креатиніну - 18 мл/хв. Результати УЗД нирок: нирки розташовані правильно, збільшені в розмірах, визначається набряк паренхіми нирок, чашково-мискова система без змін. Який патологічний стан розвинувся в дитини?

- A. Гемолітико-уремічний синдром
- B. Вірусний гепатит
- C. Хронічний гепатит

- D. Менінгококцемія
- E. Цироз печінки

75. У пацієнтки віком 14 років захворювання розпочалося гостро, з підвищення температури тіла до 38,5°C та болю в горлі. Об'єктивно спостерігається: печінка виступає з-під краю реберної дуги на 3 см, селезінка - на 2-2,5 см, усі групи шийних лімфовузлів не спаяні між собою, еластичні, не щільні, дещо болючі під час пальпації, збільшені в діаметрі від 1,0 до 2-2,5 см. За результатами гемограми виявлено виражений лімфоцитоз та 11% мононуклеарів. Установіть діагноз.

- A. Феліноз (хвороба котятих подряпин)
- B. Дифтерія
- C. Ентеровірусна інфекція
- D. Епштейна-Барр вірусна інфекція
- E. Гострий стрептококовий тонзиліт

76. У пацієнта віком 16 років, який відвідує навчальний заклад, спостерігаються жовтяниця шкіри, субіктеричність склер, гепатомегалія, потемніння сечі, ахолічний кал. З анамнезу відомо, що дитина щеплена проти гепатиту В. Упродовж місяця в дітей, які разом із ним відвідують навчальний заклад, реєструвалися подібні симптоми. Які серологічні маркери можна виявити в крові пацієнта?

- A. Анти-HBs IgG, анти-HAV IgM
- B. Анти-HAV IgG, HBsAg
- C. Анти-HCV IgM
- D. Анти-HCV IgG
- E. HBeAg

77. У чотирирічної дівчинки впродовж 3-х тижнів спостерігається сухий спазматичний кашель, що виникає раптово, переважно вночі. Напад спазматичного кашлю супроводжується репризами та закінчується відходженням густого в'язкого склоподібного мокротиння або блюванням. Установіть попередній діагноз.

- A. Туберкульоз
- B. Гострий бронхіоліт
- C. Бронхіальна астма
- D. Гострий стенозуючий ларинготрахіт
- E. Кашлюк

78. Мати двомісячної дитини скаржиться на появу в немовляти кашлю, утрудненого дихання, підвищення температури тіла. Об'єктивно спостерігається: мляве смоктання грудей, експіраторна задишка, дистанційні хрипи, тахікардія, блідість шкіри та ціаноз губ, дитина неспокійна,

плаксива. Аускультативно над легенями вислуховується жорстке дихання, розсіяні сухі свистячі та дрібноміхурцеві вологі хрипи. Перкуторно над легенями визначається коробковий звук. Експрес-тест на RS-вірус - позитивний. Установіть попередній діагноз.

- A. Гострий бронхіоліт
- B. Бронхіальна астма
- C. Внутрішньоутробна інфекція
- D. Пневмонія
- E. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

79. Дитина народилася в терміні гестації 38 тижнів, із масою тіла - 3350 г, довжиною тіла - 50 см, оцінкою за шкалою Апгар - 8-9 балів. Породілля інфікована вірусним гепатитом В, HBsAg-позитивний. Чи доцільно провести вакцинацію новонародженій дитині проти вірусного гепатиту В у пологовому будинку?

- A. Так, потрібно ввести першу дозу вакцини проти гепатиту В разом зі специфічним імуноглобуліном у різні кінцівки впродовж 12-ти год після народження
- B. Рішення про проведення вакцинації приймається після уточнення наявності інфікування дитини
- C. Вакцинацію потрібно провести у віці 2 місяці
- D. Вакцинацію потрібно провести у віці 6 місяців
- E. Дитина не потребує вакцинації у зв'язку з наявністю материнських антитіл

80. У ВІЛ-інфікованого пацієнта віком 16 років діагностовано пневмоцистну пневмонію. Оберіть лікарський засіб для лікування пневмонії в цьому разі.

- A. Амоксицилін/клавуланова кислота
- B. Препарат із групи фторхінолонів
- C. Препарат із групи карбапенемів
- D. Триметоприм/сульфаметоксазол
- E. Препарат із групи цефалоспоринів IV покоління

81. У семирічної дитини захворювання розпочалося гостро, з підвищення температури тіла до 38,0°C, втрати апетиту, з'явилися нудота, блювання, тупий біль у правому підребер'ї та епігастрії. З анамнезу відомо, що дитина вживала некип'ячену воду. На 4-у добу хвороби температура тіла нормалізувалася, сеча потемнішала, кал знебарвився. На момент огляду стан дитини задовільний, спостерігається

іктеричність склер та шкіри, живіт м'який, злегка болючий у правому підребер'ї, печінка виступає з-під краю реберної дуги на 2 см, селезінка не збільшена. Який збудник, найімовірніше, спричинив захворювання?

- A. **emphHepatitis B virus (HBV)**
- B. **emphClostridioides difficile**
- C. **emphHepatitis A virus (HAV)**
- D. **emphStreptococcus pneumoiae**
- E. **emphCytomegalovirus hominis**

82. Укажіть співвідношення компресій грудної клітки та вдихів під час проведення серцево-легеневої реанімації.

- A. 15:2
- B. 30:2
- C. 5:1
- D. 4:1
- E. 3:1

83. У тринадцятирічного пацієнта після перенесеного грипу протягом останніх 2-х тижнів спостерігаються полідипсія та поліурія, зменшення маси тіла. З діагностичною метою йому призначено лабораторне дослідження для визначення рівня глюкози в крові. Який рівень глюкози сироватки крові натще може свідчити про розвиток цукрового діабету?

- A. 8,2 ммоль/л
- B. 5,7 ммоль/л
- C. 4,0 ммоль/л
- D. 5,5 ммоль/л
- E. 3,3 ммоль/л

84. Дитину (вік - 3 місяці), у якої впродовж 3-х днів спостерігаються часті рідкі випорожнення та багаторазове блювання, шпиталізовано до відділення інтенсивної терапії. Об'єктивно спостерігається: дитина млява, сонлива, велике тім'ячко западає, діурез знижений, кінцівки холодні на дотик, шкірна складка повільно розправляється, пульс - 180/хв, ЧД - 62/хв. Укажіть стартовий розчин для інфузійної терапії.

- A. Реополіглюкін
- B. Альбумін
- C. **Ізотонічний розчин натрію хлориду**
- D. Дисоль
- E. 10%-й розчин глюкози

85. Який із нижченаведених факторів найчастіше спричиняє розвиток бронхіальної астми у дітей, молодших за три роки?

- A. Атопія до алергенів
- B. Спадковість
- C. Алергічний риніт
- D. Гіперреактивність бронхів
- E. Візінг

86. Новонароджена дитина на 4-й день життя неспокійна, не смокче груди, зригує. Об'єктивно спостерігається: здуття живота, олігурія, периферичні набряки, різко ослаблена пульсація на стегнових артеріях, систолічний АТ на верхній кінцівці - 95 мм рт. ст., на нижній - 80 мм рт. ст. Аускультативно: систолічний шум у між лопатковій ділянці. Насичення киснем артеріальної крові на верхніх кінцівках - 97%, на нижніх - 82%. На ЕКГ: гіпертрофія та систолічне перевантаження лівого шлуночка. Рентгенологічно: кардіомегалія та посилення легеневого малюнка. Установіть попередній діагноз.

- A. Відкрита аортальна протока
- B. Критичний стеноз легеневої артерії
- C. Атрезія легеневої артерії з інтактною міжшлуночковою перетинкою
- D. Тетрада Фалло
- E. Критична коарктація аорти

87. У дитини (вік - 2 місяці), яка народилася на 42 тижні гестації з масою тіла 3600 г та перебуває на грудному вигодовуванні, зберігається жовтяниця. Об'єктивно спостерігається: сухість і блідість шкіри, слабкий смоктальний рефлекс, великий живіт, виражена гіпотонія м'язів, низька температура тіла, пупкова грижа, грубий та низького тембру голос під час плачу, набряки обличчя, уповільненість рухів і рефлексів. Який найімовірніший діагноз?

- A. Синдром Криглера-Наджара
- B. Атрезія жовчних ходів
- C. Галактоземія
- D. Хвороба Жильбера
- E. Гіпотиреоз

88. Пацієнт віком 15 років скаржиться на біль у ділянці серця, задишку під час фізичних навантажень. Минулої доби вперше знепритомнів під час гри у футбол. Результати ЕхоКГ: гіпертрофія міокарда лівого шлуночка, товщина міжшлуночкової перетинки близько 16 мм, градієнт тиску у вихідному тракті лівого шлуночка - 45 мм рт. ст. (норма до 5 мм рт. ст.), ФВ - 62%. Який попередній діагноз?

- A. Гіпертрофічна кардіоміопатія з обструкцією вихідного тракту лівого шлуночка
- B. Коарктація аорти
- C. Дилатаційна кардіоміопатія
- D. Стеноз клапанів аорти
- E. Атрезія легеневої артерії з інтактною міжшлуночковою перетинкою

89. Дитина народилася в гестаційному віці 38 тижнів. Пологи відбувалися з передчасним відшаруванням нормально розташованої плаценти. Оцінка за шкалою Апгар на 1-й хвилині життя - 2 бали. Які дії потрібно провести на початку реанімаційних заходів?

- A. Забезпечити правильне положення голівки, обсушити новонародженого
- B. Спостерігати за станом життєвих функцій
- C. Провести тактильну стимуляцію
- D. Розпочати непрямий масаж серця
- E. Забезпечити вентиляцію легень під позитивним тиском

90. Чотирирічній дитині для лікування пневмонії призначено внутрішньовенне крапельне введення антибіотика. Під час інфузії стан дитини раптово погіршився, з'явилися свербіж та генералізований уртикарний висип на шкірі, набряки повік і губ. Які дії необхідно застосувати негайно?

- A. Припинити інфузію антибіотика
- B. Провести прийом Геймліха
- C. Провести кисневу терапію висококонцентрованим киснем (6-8 л/хв) через маску
- D. Провести серцево-легеневу реанімацію
- E. Увести 40%-й розчин глюкози внутрішньовенно струминно (20-40 мл)

91. Для якого типу анемії характерні жовтяниця, гепатоспленомегалія та зміна кольору (потемніння) сечі?

- A. Залізодефіцитної
- B. Апластичної
- C. Білководефіцитної
- D. Гемолітичної
- E. Гіпопластичної

92. У дванадцятирічного пацієнта протягом останніх 3-х тижнів артеріальний тиск фіксується на рівні 120/80 - 130/80 мм рт. ст., турбують головний біль, відчуття серцебиття, швидка втомлюваність, порушення зору. Яке дослідження доцільно призначити дитині насамперед для

встановлення діагнозу та призначення терапії?

- A. Добове моніторування артеріального тиску
- B. Доплерівську ехокардіографію
- C. Трансторакальну ехокардіографію
- D. Пульсоксиметрію
- E. Клінічне (офісне) вимірювання артеріального тиску

93. У семирічного хлопчика одразу після травми виникли різкий біль та збільшення в об'ємі правого колінного суглоба. Об'єктивно спостерігається: флюктуація та обмеження рухів у правому колінному суглобі. З анамнезу відомо, що в дядька хлопчика по материнській лінії виникали подібні симптоми. Результати гемограми: гемоглобін - 86 г/л, еритроцити - $3,15 \cdot 10^{12}/л$, КР - 0,82, лейкоцити - $5,5 \cdot 10^9/л$, тромбоцити - $220 \cdot 10^9/л$, ШОЕ - 7 мм/год. Час зсідання крові за Лі-Уайтом - більше 15 хв. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гемофілія Б
- B. Гемофілія А
- C. Ревматоїдний артрит
- D. Хвороба Віллебранда
- E. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура

94. Чотирирічна дитина 2 год тому впала з висоти 2 м. На момент огляду стан стабільний, за шкалою ком Глазго - 14 балів, спостерігалось дворазове блювання, на голові в ділянці тім'яної кістки справа виявлено гематому діаметром 5-6 см, вогнищева симптоматика відсутня. Укажіть подальшу тактику.

- A. У разі погіршення загального стану провести КТ головного мозку
- B. Провести МРТ головного мозку в найближчі 24 год
- C. Провести рентгенографію кісток черепа у двох проекціях
- D. Нейровізуалізацію проводити недоцільно
- E. Якнайшвидше провести КТ головного мозку

95. Пацієнта віком 15 років впродовж року турбує постійний біль у нижніх відділах живота, особливо в правій здухвинній ділянці, спостерігаються прогресуюче зменшення маси тіла та рідкі випорожнення до 5-6 разів на добу з домішками темної крові та слизу. Під час

ендоскопічного дослідження виявлено, що слизова оболонка дистального відділу клубової кишки потовщена, сегментарно гіперемована, бугриста, нерівномірно набрякла, трапляються поодинокі глибокі афтозні виразки. Для якого захворювання характерні ці симптоми та результати ендоскопічного дослідження?

- A. Неспецифічного виразкового коліту
- B. Лямбліозу
- C. Гострого апендициту
- D. Хронічного ентероколіту
- E. Хвороби Крона

96. Дитина народилася в терміні гестації 38-39 тижнів, оцінка за шкалою Апгар - 6-7 балів. На 3-тю добу після народження з'явилися зригування кров'ю, домішки крові у випорожненнях. Загальний стан дитини тяжкий, спостерігаються тахікардія та тахіпное. Оберіть тактику невідкладної допомоги.

- A. Переливання еритроцитарної маси
- B. Уведення свіжозамороженої плазми
- C. Інфузія фізіологічних розчинів
- D. Інфузія колоїдних розчинів
- E. Уведення препаратів вітаміну К

97. У шестирічної дівчинки спостерігаються підвищення температури тіла до $38,5^{\circ}\text{C}$, біль у животі без конкретної локалізації, артралгії. Під час обстеження виявлено набряк колінних суглобів, симетричний папульозно-геморагічний висип на розгинальних поверхнях кінцівок та навколо суглобів. Елементи висипу поодинокі, ущільнені, не сверблять, під час натискання не зникають. З боку інших органів та систем патологічних змін не виявлено. З анамнезу відомо, що 3 дні тому дитині проведено профілактичне щеплення проти кору, краснухи, паротиту. Установіть попередній діагноз.

- A. ДВЗ-синдром
- B. Вітряна віспа
- C. Менінгококцемія
- D. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура
- E. Геморагічний васкуліт

98. У шестирічної дитини спостерігаються періодичні епізоди болю в животі, що виникають 1 раз на тиждень протягом останніх 2-х місяців. Біль зазвичай виникає навколо пупка та може тривати декілька годин. Фізичний розвиток дитини відповідає віку, гарячка не виникає, крові в

калі не виявлено. Для якого патологічного стану характерні ці симптоми?

- A. Целиакії
- B. Непереносимості лактози
- C. Муковісцидозу
- D. Хвороби Крона
- E. Функціонального болю у животі

99. У восьмирічній дівчинки періодично виникають головний біль, запаморочення, носові кровотечі, біль у ділянці серця. Об'єктивно спостерігається: АТ на верхніх кінцівках - 165/90 мм рт. ст., на нижніх - 80/30 мм рт. ст., пульсація на стегнових артеріях різко ослаблена. Результати ЕхоКГ: гіпертрофія міокарда лівого шлуночка, градієнт тиску в нисхідній аорті - 60 мм рт. ст. (норма до 20 мм рт. ст.). Який попередній діагноз?

- A. Коарктація аорти
- B. Стеноз клапанів аорти
- C. Гіпертрофічна кардіоміопатія
- D. Дилатаційна кардіоміопатія
- E. Стеноз клапанів легеневої артерії

100. Дворічна дитина перебуває в непритомному стані. Зі слів батьків, стан дитини погіршувався поступово, спостерігалися сонливість, плаксивість, погіршення апетиту. Результати фізикального обстеження: зіниці симетрично звужені, шкіра та слизові оболонки сухі, дихання часте, шумне, поверхневе, ЧД - 38/хв, пульс ниткоподібний, ЧСС - 146/хв, гіпотонія, різкий запах ацетону з рота. Експрес-тест сечі на кетонів тіла різко позитивний. Концентрація глюкози капілярної крові - 26 ммоль/л. Який патологічний стан розвинувся в дитини?

- A. Гіпоглікемічна кома
- B. Діабетична (кетоацидотична) кома
- C. Первинний ацетонемічний синдром
- D. Пілоростеноз
- E. Діабетична (гіперлактацидемічна) кома

101. Десятирічний хлопчик під час вживання їжі раптово закашлявся. Об'єктивно спостерігається: утруднення дихання, ціаноз губ, афонія, відсутність ефективного кашлю, наростає загальна слабкість. Які заходи невідкладної допомоги необхідно застосувати негайно?

- A. Нанести до 5-ти різких ударів основою долоні між лопатками дитини
- B. Розпочати базові заходи з підтримання життя у послідовності САВ

- C. Заспокоїти дитину, дати випити води
- D. Нанести прекардіальний удар
- E. Провести інгаляцію протианбряковою сумішшю

102. Які з нижченаведених симптомів найхарактерніші для продромального періоду кору?

- A. Нежить, кашель
- B. Лущення долонь і стоп, пігментація шкіри
- C. 'Малиновий язик', 'палаючий зів'
- D. Міалгія, артралгія
- E. Діарея, біль у животі

103. У чотирирічній дитини спостерігаються біль під час та після акту дефекації, поява незначної кількості яскравої крові на калових масах, анальний свербіж. В анамнезі: функціональні закрепки. Результати копрограми: лейкоцити та слиз відсутні, еритроцити - до 40-50 в полі зору мікроскопа. Установіть попередній діагноз.

- A. Шигельоз
- B. Неспецифічний виразковий коліт
- C. Ентеробіоз
- D. Хвороба Крона
- E. Анальна тріщина

104. У пацієнтки віком 15 років спостерігається часте болісне сечовипускання, імперативні позиви до сечовипускання. Під час об'єктивного обстеження виявлено: загальний стан задовільний, живіт пальпаторно болючий у надлобковій ділянці. В аналізі сечі: виражена лейкоцитурія, бактеріурія, помірна гематурія за рахунок свіжих еритроцитів. Функції нирок збережені. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гострий пієлонефрит
- B. Хронічна ниркова недостатність
- C. Гострий гломерулонефрит
- D. Хронічний пієлонефрит
- E. Гострий цистит

105. Які біохімічні показники крові свідчать про гіпертиреоз у дитини з аутоімунним тиреоїдитом?

- A. Трийодиронін (Т3) і тироксин (Т4) підвищені, ТТГ знижений
- B. Трийодиронін (Т3) і тироксин (Т4) знижені, ТТГ знижений
- C. Трийодиронін (Т3) і тироксин (Т4) в межах норми, ТТГ підвищений

- D. Трийодиронін (Т3) і тироксин (Т4) знижені, ТТГ підвищений
 E. Трийодиронін (Т3) і тироксин (Т4) в межах норми, ТТГ знижений

106. У пацієнта віком 15 років діагноз: хронічний швидкопрогресуючий гломерулонефрит, хронічна ниркова недостатність (швидкість клубочкової фільтрації - 14 мл/хв). Виявлено виражену вторинну артеріальну гіпертензію та тяжку вторинну анемію. Запропонуйте оптимальний препарат для гіпотензивної терапії.

- A. Моксонідин
 B. Еналаприл
 C. Лерканідипін
 D. Валсартан
 E. Бісопролол

107. Під час лікування ГРВІ з метою зниження температури тіла в дитини мати восьмирічного хлопчика довгий час використовувала ацетилсаліцилову кислоту. Через тиждень після перенесеної хвороби на тлі нормальної температури тіла в дитини виникли повторне блювання та нудота, головний біль, дратівливість, тремор рук, збудження аж до делірія. Під час об'єктивного обстеження вогнищевої симптоматики не виявлено. Результати лабораторного дослідження: гіперамоніємія, підвищення активності АлАТ, АсАТ, підвищення в крові рівня глутаміна, аланіна, лейцина та жирних кислот. Який патологічний стан розвинувся в дитини?

- A. Синдром Рея
 B. Кишковий токсикоз із ексикозом
 C. Синдром Лайєлла
 D. Гострий менінгіт
 E. Гемолітико-уремічний синдром

108. У десятирічної дівчинки протягом 2-х років 2 рази на місяць виникають напади сухого кашлю та задишки. Під час нападу стан середньої тяжкості, шкіра бліда, експіраторний тип диспное, ЧД - 36/хв, тони серця ритмічні, помірно ослаблені. Перкуторно над легень визначається коробковий звук, аускультативно - сухі свистячі хрипи з обох боків, в задньонижніх відділах легень - ослаблене дихання, SaO₂ - 96%. Яку групу лікарських засобів доцільно призначити насамперед для лікування пацієнтки?

- A. Нестероїдні протизапальні та діуретики
 B. Протигрибкові та ентеросорбенти

- C. Антибіотики та відхаркувальні
 D. Холінолітики та цитостатики
 E. Інгаляційні кортикостероїди та beta₂-агоністи

109. У п'ятирічного хлопчика, який 2 місяці тому перехворів на ГРВІ, з'явилася асиметрія обличчя. Лікування у лікаря-невропатолога безрезультатне. Останні 3-4 дні дитину турбує ранковий головний біль, двічі виникало блювання. Об'єктивно спостерігається: стан тяжкий, дитина млява, шкірні покриви бліді, чисті, периферичні лімфовузли дрібні, рухливі, безболісні. Аускультативно над легень везикулярне дихання, тони серця ритмічні, звучні, вислуховується короткий систолічний шум на верхівці серця. Живіт м'який, безболісний, гепатоспленомегалія, яєчка збільшені. Виявлено ригідність потиличних м'язів, симптом Керніга слабкопозитивний з обох боків. У периферичній крові: еритроцити - $3,2 \cdot 10^{12}/л$, гемоглобін - 100 г/л, КР - 1,0, лейкоцити - $4,0 \cdot 10^{12}/л$, бластні клітини - 7%, еозинофіли - 1%, паличкоядерні нейтрофіли - 2%, сегментоядерні нейтрофіли - 7%, лімфоцити - 77%, моноцити - 6%, тромбоцити - $200 \cdot 10^9/л$, ШОЕ - 11 мм/год. Установіть попередній діагноз.

- A. Інфекційний мононуклеоз
 B. Водянка яєчка
 C. Гострий лейкоз
 D. Неврит лицевого нерва
 E. Менінгіт

110. У десятирічної дитини спостерігаються підвищення температури тіла до 38,3°C, головний біль, загальна слабкість, зниження апетиту. Під час об'єктивного обстеження виявлено: блідість шкіри, гіперемія слизової оболонки ротоглотки з ціанотичним відтінком, на обох піднебінних мигдаликах наявні фібринозні плівки з гладенькою поверхнею сірого кольору та чітко окресленими краями, тяжко знімаються шпателем, поверхня під ними кровоточить. Підщелепні лімфатичні вузли збільшені, пальпаторно болючі. Який найімовірніший діагноз?

- A. Епіглотит
 B. Інфекційний мононуклеоз
 C. Парагрип
 D. Епідемічний паротит
 E. Дифтерія

111. Пацієнт віком 17 років перебуває на лікуванні в інфекційній лікарні з діагнозом: локалізована дифтерія ротової частини глотки. З анамнезу відомо, що останнє щеплення проти цього захворювання проводилося вакциною АДП-М у віці 6 років. Коли найдоцільніше провести пацієнту наступне щеплення проти дифтерії?

- A. До моменту виписки зі стаціонару
- B. Повторне щеплення проводити не доцільно у зв'язку з формуванням стійкого імунітету
- C. Через 1 рік
- D. Через 10 років
- E. Через 6 місяців після визначення рівня захисних антитіл

112. Дитина народилася від II пологів у терміні гестації 37-38 тижнів із масою тіла - 3100 г, довжиною тіла - 53 см. Під час пологів у матері спостерігалось підвищення температури тіла до 38°C. Через 8 годин після народження стан дитини погіршився та з'явилися такі клінічні прояви: кволий смоктальний рефлекс, блідо-сірий колір та мармуровість шкіри, здуття живота, зригування, набряковий синдром, ЧД - 74/хв, ЧСС - 180/хв. Результати загального аналізу крові: гемоглобін - 155 г/л, еритроцити - $3,9 \cdot 10^{12}/л$, тромбоцити - $130 \cdot 10^9/л$, лейкоцити - $24,8 \cdot 10^9/л$, юні нейтрофіли - 8%, паличкоядерні нейтрофіли - 22%, сегментоядерні нейтрофіли - 36%, еозинофіли - 2%, лімфоцити - 31%, моноцити - 1%, ШОЕ - 8 мм/год. Який найімовірніший діагноз?

- A. Ранній неонатальний сепсис
- B. Респіраторний дистрес-синдром
- C. Вроджена пневмонія
- D. Внутрішньочерепний крововилив
- E. Пізній неонатальний сепсис

113. Десятирічна дівчинка втратила свідомість у навчальному закладі. Об'єктивно спостерігається: шкірні покриви бліді, холодні на дотик, краплі поту на обличчі, зіниці розширені, АТ - 90/50 мм рт. ст., пульс - 60/хв. Який патологічний стан виник у дитини?

- A. Токсична енцефалопатія
- B. Синдром Морганьї Адамса-Стокса
- C. Анафілактичний шок
- D. Непритомність
- E. Симпатикотонічний колапс

114. У трирічній дівчинки спостерігаються підвищення температури тіла до 38,6°C, млявість, зниження апетиту. Захворіла раптово, 2 дні тому. Під час об'єктивного обстеження виявлено: загальний стан середнього ступеня тяжкості, ЧД - 32/хв, ЧСС - 126/хв. Попередній діагноз: гострий пієлонефрит. Які біохімічні показники вказують на інфекцію сечовивідних шляхів у разі тестування сечі за допомогою тест-смужок?

- A. Лейкоцитарна естераза і нітрити позитивні
- B. Лейкоцитарна естераза і нітрити негативні
- C. Лейкоцитарна естераза негативна, нітрити позитивні
- D. Лейкоцитарна естераза позитивна, нітрити негативні
- E. -

115. У якій ділянці голови в дітей рідко локалізується біль, що вимагає додаткового дообстеження?

- A. Тім'яній
- B. Скроневій
- C. Потиличній
- D. Лобно-скроневій
- E. Лобній

116. Пацієнта віком 14 років турбує печія, що посилюється після фізичних вправ із нахилами тулуба та вживання смаженої їжі, газованих напоїв. Який метод ранньої діагностики патологічного гастро-езофагеального рефлюксу доцільно призначити для уточнення діагнозу?

- A. Добове рН-моніторування стравоходу
- B. Прицільну біопсію слизової оболонки стравоходу
- C. Фіброгастродуоденоскопію
- D. Рентгенографію органів шлунково-кишкового тракту
- E. Ультразвукове дослідження шлунково-кишкового тракту

117. Під час профілактичного огляду восьмирічного хлопчика лікар-педіатр не виявив ознак гострого захворювання. Дитині проведено всі щеплення відповідно до віку згідно з Національним календарем профілактичних щеплень. Алергоанамнез не обтяжений. Під час опитування пацієнта з'ясувалося, що він місяць тому перехворів на ГРВІ, бронхіт. Чи дозволено наразі провести цій дитині профілактичне щеплення проти COVID-19?

- A. Так, вакцинація проти COVID-19 дозволена дітям від 1 року
- B. Ні, вакцинація проти COVID-19 дозволена дорослим від 18 років
- C. Ні, вакцинацію проти COVID-19 дитині потрібно провести не раніше ніж через 1,5 місяці після зникнення симптомів ГРВІ, бронхіту
- D. Ні, вакцинація проти COVID-19 дозволена лише дітям від 12 років
- E. Так, вакцинація проти COVID-19 дозволена дітям віком від 5 років

118. У шестирічного хлопчика спостерігаються підвищення температури тіла до 38°C та поява екзантеми на шкірі. Елементи висипу спочатку мають вигляд рожевих плям, але швидко еволюціонують у папули та везикули. Довкола везикул є вузька смужка гіперемії. Екзантема локалізується на шкірі тулуба, обличчі, шиї, кінцівках, слизових оболонках та на волосистій частині голови. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

- A. Кору
- B. Менінгококцемії
- C. Вітряної віспи
- D. Кропив'янки
- E. Синдрому Кавасаки

119. У чотирирічної дитини спостерігається підвищення температури тіла до 38,2°C, біль у горлі під час ковтання, головний біль та блювання. Під час об'єктивного обстеження виявлено яскраву гіперемію слизової оболонки ротоглотки, гіпертрофію мигдаликів, блідість носогубного трикутника, яскраво-червоний язик із гіпертрофованими сосочками ('малиновий язик'), на шкірі бічних поверхонь тулуба та в місцях природних складок локалізується рясний дрібнокрапковий висип. З боку інших органів та систем змін не виявлено. Установіть попередній діагноз.

- A. Скарлатина
- B. Атопічний дерматит
- C. Менінгококцемія
- D. Кір
- E. Краснуха

120. Укажіть найпоширеніший збудник, що спричиняє інфекції сечовивідних шляхів у дітей.

- A. Протей
- B. Кишкова паличка
- C. Синьогнійна паличка

- D. Клебсієла
- E. Ентерококи

121. У пацієнтки віком 15 років спостерігаються підвищення температури тіла, нездужання, озноб, продуктивний кашель протягом 4-х днів із виділенням помірної кількості жовтого мокротиння. Останні 2 дні турбує біль у грудній клітці з правого боку, що посилюється під час глибокого вдиху. Під час об'єктивного обстеження виявлено: температура тіла - 38,8°C, пульс - 82/хв, ЧД - 20/хв, SaO₂ - 99%, аускультативно над правою легенею вислуховуються дрібноміхурцеві хрипи. Результати рентгенографії ОГК: інфільтрат в основі правої легені. Оберіть найдоцільнішу тактику лікування пацієнтки.

- A. Стаціонарне лікування (цефтріаксон внутрішньовенно та азитроміцин перорально)
- B. Амбулаторне лікування (цефтріаксон внутрішньовенно)
- C. Амбулаторне лікування (левофлоксацин)
- D. Амбулаторне лікування (амоксацилін перорально)
- E. Стаціонарне лікування (цефепім внутрішньовенно)

122. Як називаються судоми, що часто виникають у дітей молодшого віку на тлі підвищення температури тіла?

- A. Гіпокальціємічні
- B. Гіпоглікемічні
- C. Структурні
- D. Фебрильні
- E. Епілептичні

123. Пацієнта віком 14 років шпиталізовано на дообстеження у відділення дитячої кардіології зі скаргами на напади прискореного серцебиття до 190/хв. З анамнезу відомо, що рідний брат матері помер раптово у віці 29 років. Об'єктивно спостерігається: ІМТ - 18,9 кг/м², шкіра і слизові блідо-рожевого кольору, чисті, ЧСС - 110/хв, ЧД - 16/хв, АТ - 100/70 мм рт. ст., серцеві тони приглушені, ритмічні. На ЕКГ: ритм синусовий, ознаки блокади правої ніжки пучка Гіса і передньої гілки лівої ніжки. Під час УЗД серця структурних змін не виявлено, фракція викиду лівого шлуночка - 50%. Запропонуйте оптимальний метод для дообстеження пацієнта.

- A. ПЕТ-КТ
- B. Катетеризація
- C. МРТ
- D. КТ
- E. Коронарографія

124. У десятирічної дівчинки протягом останніх 3-х місяців спостерігаються стійкий біль, набряк та скутість у великих суглобах (колінних, ліктьових). Біль посилюється вранці та після тривалого сидіння. Останні 10 днів помічала обмеження рухів у колінних суглобах. Який найімовірніший діагноз?

- A. Остеомієліт
- B. Хвороба Кавасакі
- C. Подагра
- D. Ювенільний ідіопатичний артрит
- E. Травма колінного суглоба

125. Який патологічний стан, у разі підтвердженої алергії на білок коров'ячого молока, належить до реакції негайного типу?

- A. Риніт
- B. Кишкова колика
- C. Діарея
- D. Ентероколітичний синдром
- E. Закреп

126. У дитини (вік - 11 місяців) захворювання розпочалося гостро, з підвищення температури тіла до 38,8°C, появи кашлю та нежитю. На 2-й день хвороби, вночі, стан різко погіршився, дитина стала неспокійною, розвинулося утруднене дихання, 'гавкаючий' кашель, хрипкість голосу, інспіраторна задишка. Установіть діагноз.

- A. Обструкція дихальних шляхів стороннім тілом
- B. Епіглотит
- C. Гострий бронхіоліт
- D. Гострий обструктивний бронхіт
- E. Гострий стенозуючий ларинготрахеїт

127. У семирічної дитини спостерігаються спрага, постійне відчуття голоду, часте сечовипускання, сухість та свербіж шкіри, втрата маси тіла. Під час об'єктивного обстеження виявлено: шкірні покриви та слизові оболонки рожеві, сухі, еластичність шкіри та тургор м'яких тканин незначно знижені, ЧД - 24/хв, легкий запах ацетону з рота, ЧСС - 95/хв, печінка виступає з-під краю реберної дуги на 3 см, селезінка не збільшена. Рівень глюкози в крові натще - 7,5 ммоль/л, глікований гемоглобін

(HbA1c) - 8,5%. Установіть попередній діагноз.

- A. Порушення глікемії натще
- B. Цукровий діабет 1-го типу
- C. Порушення толерантності до глюкози
- D. Цукровий діабет 2-го типу
- E. Нецукровий діабет

128. У пацієнтки віком 14 років діагностовано виразкову хворобу дванадцятипалої кишки. *emphHelicobacter pylori* тест - позитивний. Який із нижченаведених препаратів використовується в терапевтичній схемі для ерадикації *emphHelicobacter pylori*?

- A. Дротаверин
- B. Стрептоміцин
- C. Амоксицилін
- D. Метаклопрамід
- E. Ніфуроксазид

129. У новонародженої дитини на 4-му тижні життя з'являється блювання 'фонтаном' через 30 хв після годування. Кількість блювотних мас, як правило, перевищує кількість молока, вжитого під час останнього годування. Апетит збережений, дитина постійно неспокійна. Для якої патології характерні ці симптоми?

- A. Пілоростенозу
- B. Адреногенітального синдрому
- C. Пілороспазму
- D. Атрезії стравоходу
- E. Лактазної недостатності

130. Оберіть правильну тактику щодо вакцинації новонароджених дітей вакциною БЦЖ проти туберкульозу в пологовому будинку.

- A. Діти, що народилися раніше 33 тижня гестації, не отримують щеплення БЦЖ, поки не настане 33 тиждень гестації
- B. Діти, що народилися раніше 34 тижня гестації, не отримують щеплення БЦЖ, поки не настане 34 тиждень гестації
- C. Діти, що народилися раніше 35 тижня гестації, не отримують щеплення БЦЖ, поки не настане 35 тиждень гестації
- D. Діти, що народилися раніше 32 тижня гестації, не отримують щеплення БЦЖ, поки не настане 32 тиждень гестації
- E. Діти отримують щеплення БЦЖ винятково після виписки з пологового будинку

131. У десятимісячної дівчинки фіксуються такі антропометричні показники: маса тіла - 8000 г, довжина тіла - 67 см, обвід голови - 45 см, обвід грудної клітки - 46 см. Об'єктивно спостерігається: шкіра помірно бліда, суха на дотик, еластичність її знижена, підшкірний жировий шар зменшений на животі, трохи на тулубі. Дитина відстає в нервово-психічному розвитку на 2 міс. З анамнезу відомо, що у матері розвинулася гіпогалактія в 1,5-місячному віці дитини, тому вона годувала її кип'яченим коров'ячим молоком та рідкою манною кашею, жодних прикормів дитині не вводилося. Дитина народилася з масою тіла - 2800 г, довжиною тіла - 47 см, обводом голови - 34 см, обводом грудної клітки - 34 см. Установіть попередній діагноз.

- A. Мікроцефалія
- B. Паратрофія II ступеня
- C. Гіпотрофія II ступеня
- D. Гіпостатура
- E. Ожиріння I ступеня

132. У трирічної дівчинки спостерігаються загальна слабкість, дефіцит маси тіла та рідкі випорожнення 3-4 рази на добу. В анамнезі: часті респіраторні захворювання. Під час об'єктивного обстеження виявлено: блідість та сухість шкірних покривів, синці під очима, серцеві тони ритмічні, приглушені, дихання жорстке, ослаблене, хрипів немає, живіт збільшений у розмірах, не болючий, печінка виступає з-під краю реберної дуги на 3,0 см, край її заокруглений. Результати копрограми: нейтральний жир - +++++, крохмаль - +++, неперетравлені м'язові волокна - ++. Рівень хлоридів поту - 64 ммоль/л. Який найімовірніший діагноз?

- A. Целіакія
- B. Муковісцидоз
- C. Алактазія
- D. Фенілкетонурія
- E. Галактоземія

133. Дворічна дитина перебуває на лікуванні в інфекційній лікарні з діагнозом: ротавірусна інфекція, гемоколіт. Незважаючи на проведені лікування, стан дитини прогресивно погіршується. Об'єктивно спостерігається: стан тяжкий, свідомість збережена, шкірні покриви бліді, чисті, ЧД - 32/хв. Дихання везикулярне. Гемодинаміка компенсована. Тони серця приглушені, вислуховується систолічний шум на верхівці серця, ритм правильний. Живіт м'який, гепатомегалія,

селезінка не збільшена. Олігурія, сеча бурого кольору. Кал із прожилками крові. Яка комбінація симптомів дозволить припустити розвиток гемолітико-уремічного синдрому в дитини?

- A. Гіпербілірубінемія, сечовий синдром, тромбоцитоз
- B. Мікроангіопатична гемолітична анемія, набряковий синдром, тромбоцитоз
- C. Залізодефіцитна анемія, ниркова недостатність, тромбоцитоз
- D. Мікроангіопатична гемолітична анемія, лейкоцитурія, тромбоцитопенія
- E. Мікроангіопатична гемолітична анемія, ниркова недостатність, тромбоцитопенія

134. У чотирирічної дівчинки спостерігаються виражена спрага, рясне та часте сечовипускання, енурез, загальна слабкість та погіршення апетиту. Після повного медичного обстеження встановлено діагноз: нецукровий діабет. Які лікарські засоби доцільно призначити дитині насамперед?

- A. Кортикостероїди
- B. Гіпоглікемічні препарати
- C. Препарати вазопресину
- D. Агоністи дофамінових рецепторів
- E. Інсулін пролонгованої дії

135. Пацієнт віком 13 років скаржиться на нестерпний біль у правому колінному суглобі, що виник через годину після травми. Об'єктивно спостерігається: уражений суглоб збільшений, деформований, гіперемований. Наявні прояви артропатії в інших суглобах. З анамнезу відомо, що по лінії матері в осіб чоловічої статі спостерігалися подібні симптоми. У периферичній крові: еритроцити - $3,9 \cdot 10^{12}/\text{л}$, гемоглобін - 130 г/л, КП - 1,0, лейкоцити - $5,6 \cdot 10^9/\text{л}$, тромбоцити - $220 \cdot 10^9/\text{л}$, ШОЕ - 6 мм/год. Час зсідання крові за Лі-Уайтом: початок - 22 хв, кінець - 28 хв. Який лікарський засіб необхідно насамперед призначити дитині?

- A. Фактор зсідання крові VIII
- B. Вікасол
- C. Еритроцитарна маса
- D. Дицинон
- E. Консервована кров

136. Пацієнтку віком 15 років, яка хворіє на цукровий діабет 1-го типу та отримує інсулін, шпиталізовано до лікарні в неpritомному стані. З'ясувалося, що після

введення інсуліну вона не поїла. Через 1,5 год з'явилися запаморочення, сонливість та втрата свідомості. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, 'холодний піт', дихання поверхнєве, гіпертонус м'язів, судоми. Який патологічний стан розвинувся в дитини?

- A. Гостра серцево-судинна недостатність
- B. Епілесія
- C. Гостра надниркова недостатність
- D. Гіпоглікемічна кома
- E. Гіперглікемічна кетоацидотична кома

137. У десятирічної дитини через 10 днів після початку застуди продовжуються слизово-гнійні виділення з носа, біль у ділянці обличчя, сильний головний біль і продуктивний кашель, що турбує більше в нічний час, неприємний запах з носа і рота. Температура тіла в межах 37,5-38,0°C. Який найімовірніший діагноз?

- A. Гострий риносинусит
- B. Гострий менінгіт
- C. Пневмонія
- D. Кашлюк
- E. Гострий фарингіт

138. Тринадцятирічного пацієнта турбують рідкі випорожнення до 6-ти разів на добу з домішками слизу та крові, переймоподібний біль у лівій частині живота, зниження апетиту, біль у суглобах, загальна слабкість, періодичне підвищення температури тіла до субфебрильних цифр. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, зменшення маси тіла, ліві відділи товстого кишечника пальпаторно болючі. У периферичній крові: гемоглобін - 90 г/л, ШОЕ - 35 мм/год. Під час ректороманоскопії виявлено набряк та гіперемію слизової оболонки прямої та сигмоподібної кишок, виразково-некротичні зміни, контактна кровотеча. Укажіть групу препаратів першої лінії, які потрібно застосувати для лікування пацієнта в цьому разі.

- A. Ентеросорбенти
- B. Кортикостероїди
- C. Аміносаліцилати
- D. Цитостатики
- E. Антибіотики

139. Дитина (вік - 3 місяці), яка хворіє на гострий бронхіоліт, лікується амбулаторно. На момент огляду об'єктивно спостерігається: ЧД - понад 60/хв, погано смокче грудне молоко, дегідратація відсутня, SaO₂ - 93%. Яку тактику

потрібно застосувати щодо цієї дитини насамперед?

- A. Шпиталізувати лише у разі появи апное або ЧД понад 70/хв
- B. Надати інформацію щодо догляду за дитиною вдома
- C. Направити на консультацію до фтизіатра
- D. Направити на консультацію до алерголога
- E. Негайно шпиталізувати

140. У доношеної новонародженої дитини спостерігається ціаноз із перших хвилин життя, швидко прогресує задишка, тахікардія. Перебіг вагітності та пологів без ускладнень. Під час аускультатії легень дихання рівномірно проводиться в праву та ліву легені, вологі дрібноміхурцеві хрипи з обох боків, серцеві шуми відсутні, SaO₂ - 78%. Гіпероксичний тест негативний. Результати рентгенографії органів грудної клітки: збагачений легеневий малюнок, помірна кардіомегалія, тінь серця яйцеподібної форми з вузьким судинним пучком. Який найімовірніший діагноз?

- A. Транспозиція магістральних судин
- B. Тетрада Фалло
- C. Вроджена пневмонія, міокардит
- D. -
- E. Відкрита артеріальна протока

141. У дитини (вік - 1 рік і 3 місяці) захворювання розпочалося гостро, з підвищення температури тіла до 40°C) Через 3 дні, на тлі зниження температури, з'явився макулопапульозний рожевий висип із переважною локалізацією на тулубі. Елементи висипу зберігалися протягом 3-х днів та зникли безслідно. Попередній діагноз: раптова екзантема. Укажіть збудника цього захворювання.

- A. beta-гемолітичний стрептокок групи А
- B. Герпес вірус людини 6-го типу
- C. Герпес вірус людини 3-го типу
- D. Вірус Епштейна-Барр
- E. Парвовірус В19

142. Яка форма церебрального паралічу найчастіше формується у передчасно народжених дітей?

- A. Дискінетичний церебральний параліч
- B. Спастична тетраплегія
- C. Атактичний церебральний параліч
- D. Спастична геміплегія
- E. Спастична диплегія

143. До лікаря звернулася мати дворічного хлопчика зі скаргами на посилення в дитини продуктивного кашлю з виділенням помірної кількості білого мокротиння протягом останнього тижня. За останній рік дитина 4 рази хворіла на пневмонію та лікувалася антибіотиками. Мати помічала декілька епізодів, об'ємних, жирних випорожнень із неприємним запахом. Об'єктивно спостерігається: шкіра бліда, температура тіла - 38°C, пульс - 132/хв, ЧД - 44/хв. Аускультативно над легеньми вислуховуються поодинокі вологі дрібноміхурцеві хрипи. Живіт м'який, безболісний. Тони серця гучні, ритмічні. Печінка і селезінка не збільшені. Випорожнення і сечовипускання не порушені. Яке дослідження найдоцільніше провести насамперед для уточнення діагнозу?

- A. Визначення хлоридів у потовій рідині
- B. Дослідження калу на приховану кров
- C. Комп'ютерну томографію органів грудної клітки
- D. УЗД легень
- E. Функціональні проби дихальної системи

144. У десятирічної дитини з діагнозом: міокардит, на ЕКГ фіксується подовження інтервалу PQ до 0,28 с та інверсія зубця Т в грудних відведеннях. Яка функція міокарда порушена?

- A. Скоротлива здатність
- B. Збудливість
- C. Провідність
- D. -
- E. Автоматизм

145. Дитині (вік - 4 місяці) діагностовано тетраду Фалло та проведено радикальну операцію. Через 48 год після операції виник епізод тахікардії з ЧСС 280/хв, що на моніторі мав вигляд тахікардії з вузьким комплексом QRS і супроводжувався порушеннями гемодинаміки. Який варіант суправентрикулярної тахікардії виник у дитини?

- A. АВ-вузлова ріентрі тахікардія
- B. Синусова ріентрі тахікардія
- C. Передсердна тахікардія
- D. АВ-ріентрі тахікардія
- E. Вузлова ектопічна тахікардія

146. У семирічної дитини, яка хворіє на гострий гломерулонефрит, спостерігаються виражені набряки під очима та на гомілках. За результатами

гемограми виявлено нормохромну анемію І ступеня тяжкості, нейтрофільний лейкоцитоз, ШОЕ - 30 мм/год. Добовий білок в сечі - 4,5 г/добу. АТ - 100/60 мм рт. ст. Препарати якої групи використовуються для патогенетичної терапії в цьому разі?

- A. Глюкокортикоїди
- B. Гіпотензивні
- C. Діуретики
- D. Антигістамінні
- E. Антибіотики

147. Пацієнта віком 12 років протягом 2-х років періодично турбують біль у верхній частині живота, що частіше виникає натще або вночі ('голодний біль'), нудота, блювання. Батько пацієнта має подібні скарги, але не обстежувався. Установіть попередній діагноз.

- A. Шигельоз
- B. Неспецифічний виразковий коліт
- C. Гострий апендицит
- D. Функціональна диспепсія
- E. Виразкова хвороба шлунка

148. Для якої патології характерні діастолічна дисфункція та нормальна систолічна функція серця?

- A. Дефекту міжшлуночкової перетинки
- B. Аортального стенозу
- C. Тяжкої мітральної недостатності
- D. Аортальної недостатності
- E. Кардіоміопатії

149. У п'ятирічної дівчинки після перенесеної ГРВІ з'явилися носова кровотеча та поліморфний, поліхромний несиметричний висип (петехії та екхімози) на тулубі і кінцівках. Лімфатичні вузли не збільшені. Патології з боку шлунково-кишкового тракту не виявлено. У периферичній крові: гемоглобін - 105 г/л, еритроцити - $3,3 \cdot 10^{12}/л$, лейкоцити - $7,2 \cdot 10^9/л$, тромбоцити - $25 \cdot 10^9/л$. Час зсідання крові за Лі-Уайтом - 7 хв, час кровотечі по Дюке - 9 хв, позитивна проба джгута (15 петехій). Установіть діагноз.

- A. Геморагічний васкуліт
- B. ДВЗ-синдром
- C. Гемолітико-уремічний синдром
- D. Хвороба Віллебранда
- E. Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура

150. Пацієнтка віком 14 років, яка хворіє на бронхіальну астму, скаргиться на біль у

грудній клітці та епізоди утрудненого дихання, що посилюються в горизонтальному положенні, іноді турбують печія та відрижка. Симптоми розглядалися як прояви бронхіальної астми, проте звичні методи лікування були не ефективні. Оберіть найдоцільнішу терапевтичну тактику в цьому разі.

- A. Призначення ентеросорбентів
- B. Інгаляційне введення beta_2-адреноміметиків
- C. Інгаляційне введення глюкокортикоїдів
- D. Пробне застосування прокінетиків
- E. 4-тижневе призначення інгібіторів протонної помпи або антагоністів H_2-рецепторів гістаміну